

जनन स्वास्थ्य

अध्याय 3 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



अभ्यास

Q

3.1

Importance
of
reproductive
health

समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्त्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए?

जनन स्वास्थ्य का महत्त्व

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation : W.

H.

O.

) के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक सम्पूर्ण स्वास्थ्य, यानी शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य।

इसका महत्त्व इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है।

इसे निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

(a) जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधकों का प्रचार-प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है।

(b) यह किशोरावस्था की समस्याओं से निबटने में कारगर भूमिका निभाता है।

(c) सहायक जनन प्रौद्योगिकियों द्वारा बन्ध्य दम्पतियों को संतान प्राप्ति के अवसर दिलाता है।

(d) यौन संचरित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा कर जनमानस को इनसे बचाने में सहायक है।

(e) यह मेन्स्ट्रुएशन, गर्भाधान, सगर्भता, प्रसव आदि से सम्बन्धित परामर्श व चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

Q

3.2

Aspects of
reproductive
health
needing
attention

जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएँ, जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है?

निष्कर्ष

अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समस्याएँ, भौतिक संसाधनों की कमी तथा सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन-दुराचार (sex-abuse) एवं यौन-सम्बन्धी अपराध (sex-related crimes) होते हैं।

इनके विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

इससे व्यक्ति इन्हें रोकने के लिए सोचेंगे और आवश्यक कदम उठाएँगे, जिससे जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज बनेगा।

समाज को जनन सम्बन्धी समस्याओं जैसे सगर्भता (pregnancy), प्रसव (delivery), यौन संचारित रोगों (Sexually Transmitted Diseases : STD), गर्भपात (abortions), गर्भनिरोधकों (contraceptives), ऋतुसाव-सम्बन्धी समस्याओं (menstrual problems), बाँझपन (infertility) आदि के बारे में चिकित्सा सहायता व देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है।

इसके लिए समय-समय पर बेहतर तकनीक और नवीन कार्य-नीतियाँ अपनानी होंगी, जिससे लोगों की अधिक अच्छी देखभाल और सहायता की जा सके।

इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सभी प्रकार के लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबन्ध आवश्यक है।

बाल प्रतिरक्षीकरण (child immunization) आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

Q

3.3

Is sex
education
necessary in
schools

क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है ? यदि हाँ तो क्यों?

निष्कर्ष

अध्ययन बताते हैं कि अपने देश में आधी आबादी 25 वर्ष से कम के व्यक्तियों की है। 15-25 वर्ष के लोग यौन संचरित रोगों का भी शिकार अधिक बनते हैं। अतः विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे युवाओं में यौन-सम्बन्धी विभिन्न भ्रान्तियाँ दूर होंगी और उन्हें यौन-सम्बन्धी सही जानकारी मिलेगी। किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। सही जानकारी न होने पर किशोर-युवा इधर-उधर से गलत जानकारी लेकर गलत रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए सतर्कता आवश्यक है ताकि वे अपने लक्ष्य को पाएँ, हास्यास्पद न हो जाएँ।

किशोरावस्था में व्यक्तियों को जनन अंगों की जानकारी, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचरित रोगों (STD), एड्स आदि के सम्बन्ध में जानकारी देना जनन सम्बन्धी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। इससे सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलती है।

Q

3.4

Improvement
in
reproductive
health over
50 years

क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए?

निष्कर्ष

भारतवर्ष में सम्पूर्ण जनन स्वास्थ्य के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन् 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया। समय-समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती रही है। इसे और अधिक उन्नत व व्यापक बनाने के लिए वर्तमान में इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (Reproductive and Child Healthcare : RCH) के नाम से जानते हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में व्यक्तियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न की जा रही है और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकारी और सामाजिक संगठन श्रव्य तथा दृश्य (audio-visual) और छपी हुई सामग्री (print media) की सहायता से जनता को जनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दे रहे हैं।

जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन-सम्बन्धित मामलों में बेहतर जागरूकता आई है। अधिकाधिक संख्या में प्रसव अब चिकित्सा सहायता के साथ हो रहे हैं और प्रसवोत्तर देखभाल (post-natal care) भी बेहतर हुई है, जिससे माता और शिशु की मृत्युदर में गिरावट आई है। छोटे परिवार वाले जोड़ों (couples) की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति छोटे परिवार के महत्त्व को समझ रहे हैं। यौन संचरित रोगों की सही जाँच-पड़ताल, देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण समाज के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है।

Q

3.5

Causes of
population
explosion

जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं?

जनसंख्या विस्फोट

जनसंख्या विस्फोट
(Population Explosion)

विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकण्ड या 2,00,000 व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रतिमाह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है।

निष्कर्ष

जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण (Increase in population and its reasons)
जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं-

(i) स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate : IMR) एवं मातृ मृत्युदर (Maternal Mortality Rate : MMR) में कमी आयी है।

(ii) जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना।

(iii) अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार के कारण।

(iv) अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना।

(v) वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि।

(vi) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना।

(vii) निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे, वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे।

(viii) सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दम्पती सन्तान उत्पन्न करते रहते हैं।

Q

3.6

Is
contraceptive
use
justified

क्या गर्भनिरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताएँ।

निष्कर्ष

गर्भ निरोधक शरीर की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को रोककर काम करते हैं, जिससे शरीर पर कुछ प्रत्यक्ष-परोक्ष परिणाम होते हैं। इनका प्रयोग प्राकृतिक गर्भाधान व सगर्भता के विरुद्ध किया जाता है।

लेकिन कुछ व्यक्ति दो सन्तानों के बीच अन्तर रखने अथवा गलती से हुई सगर्भता की स्थिति से बचने हेतु गर्भ निरोधकों का प्रयोग करते हैं।

ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है।

अतः गर्भ निरोधकों का प्रयोग एक अनावश्यक आवश्यकता (unnecessary necessity) कहा जा सकता है।

यह जनन स्वास्थ्य के रखरखाव व स्वास्थ्य की आवश्यकता कदापि नहीं है।

Q

3.7

Gonad
removal is
not a
contraceptive
alternative

जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है? क्यों?

निष्कर्ष

जनन अंग (ग्रन्थि-goands) सन्तान उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं।

वृषण में शुक्राणुओं तथा अण्डाशय में अण्डाणुओं का उत्पादन होता है।

साथ ही ये अन्तःस्रावी ग्रन्थि की तरह भी काम करते हैं।

गर्भनिरोधकों का उपयोग सन्तति नियन्त्रण के लिए किया जाता है।

संतति नियन्त्रण के लिए जनन अंगों (gonads) को हटाना गर्भनिरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता।

इसका कारण यह है कि जनन अंगों से निकलने वाले लिंग हॉर्मोन्स शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इन हॉर्मोन्स की कमी से मानसिक और शारीरिक समस्याएँ हो सकती हैं।

एक गर्भनिरोधक का काम युग्मकों को आपस में मिलने से रोकना है।

यह निषेचन, सगर्भता या अन्तरोपण को भी रोकता है।

इसका काम युग्मक उत्पादन रोकना नहीं है।

अतः जनदों का हटाना गर्भनिरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता।

अन्य गर्भनिरोधक विधियाँ आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए उनका उपयोग करना सरल है।

इसके विपरीत, जनन अंगों को हटाना एक जटिल शल्य प्रक्रिया है।

अतः जननांगों (gonads) को हटाना गर्भनिरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता।

Q

3.8

Amniocentesis
is for sex
determination

उल्लेखन एक घातक लिंग निर्धारण (जाँच) प्रक्रिया है, जो हमारे देश में निषेधित है? क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें।

उल्लेखन

उल्लेखन (Amniocentesis)-भ्रूण (embryo) एक एम्नियोटिक तरल (amniotic fluid) में तैरता रहता है। इन्जेक्शन सुई की सहायता से माता के गर्भाशय में से इस तरल का एक सैम्पल ले लिया जाता है। तरल में स्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात् कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अनेक बार जब यह पता चलता है कि भ्रूण मादा है, तो एमटीपी (Medical Termination of Pregnancy—चिकित्सीय सगर्भता समापन) द्वारा भ्रूण को गिरा दिया जाता है। इससे समाज में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात बिगड़ने की सम्भावना बढ़ रही है। बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं को देखते हुए यह प्रतिबन्ध आवश्यक है। हमारा संविधान लिंग के आधार पर भेद करने की आज्ञा नहीं देता। नैतिकता की दृष्टि से भी यह एक सभ्य समाज में घृणित अपराध है। अतः इस पर रोक उचित है।

Q

3.9

Assisted
reproductive
methods for
infertile
couples

बन्ध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ बताएँ।

बन्धता (Sterility)

भारतवर्ष सहित विश्व में अनेक दम्पती बन्ध (sterile) हैं अर्थात् वे सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। यह शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक (immunological) या मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकता है। यह पुरुष या स्त्री में पाए जाने वाले दोष के कारण हो सकता है।

मान रखो

अनेक प्रकार की बन्धताओं का उपचार केवल औषधियों से हो जाता है। कभी-कभी परामर्श व मनोवैज्ञानिक उपचार भी सहायक होता है।

सहायक जनन प्रौद्योगिकी (ART)

प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ (बन्धता क्लीनिक — infertility clinics) निदानिक जाँच में सहायता करती हैं। ये उपचार करके बन्ध दम्पतियों को सन्तान पैदा करने में मदद देती हैं। इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technologies : ART) कहते हैं।

IVF/ET, IUT

शरीर से बाहर निषेचन को पात्रे निषेचन (In Vitro Fertilization : IVF) कहते हैं। इसके बाद भ्रूण को स्थानान्तरित (Embryo Transfer : ET) किया जाता है। यह बन्ध दम्पतियों के लिए एक उपयुक्त उपाय हो सकता है। इस तकनीक को सामान्यतः टेस्ट ट्यूब बेबी (test tube baby) तकनीक कहते हैं। प्रयोगशाला में पत्नी या दाता के अण्ड को पति या दाता के शुक्राणु से निषेचित कराया जाता है। इसके बाद युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरित किया जाता है। जब भ्रूण 8 कोशिकाओं से अधिक विकसित हो जाता है, तो उसे गर्भाशय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसे इन्ट्रा यूटेराइन ट्रांसफर (Intra Uterine Transfer : IUT) कहते हैं।

GIFT

जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है, उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन (in-vivo fertilization) द्वारा बने भ्रूण को उनके गर्भाशय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। कुछ स्त्रियों में अण्डाणु नहीं बनते, लेकिन वे निषेचन और भ्रूणीय विकास के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए दाता स्त्री से अण्डाणु लेकर उसे इसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसे गैमीट इन्ट्रा फैलोपियन ट्रांसफर (Gamete Intra Fallopian Transfer : GIFT) कहते हैं।

निष्कर्ष

कृत्रिम वीर्यसेचन तकनीक तब प्रयोग की जाती है, जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो या पुरुष वीर्य सेचित करने में असमर्थ हो। इस तकनीक में दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसे अन्तःगर्भाशयी वीर्यसेचन (Intra Uterine Insemination : IUI) कहते हैं। ZIFT तथा ICSI भी ऐसी ही कुछ अन्य तकनीकें हैं।

वर्तमान में ये तकनीकी सुविधाएँ अनेक शहरों में उपलब्ध हैं, लेकिन ये बहुत महँगी हैं।
इन तकनीकों को अपनाने में सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Q

3.10

Avoiding exposure to sexually transmitted diseases

किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए?

निष्कर्ष

यौन सम्बन्धों के कारण संचारित रोग यौन संचारित कहलाते हैं।

इन्हें सामान्यतया एस०टी०डी० (Sexually Transmitted Diseases : STD) या रतिज रोग (Venereal Disease) या जनन मार्ग संक्रमण (Reproductive Tract Infections : RTI) कहते हैं।

बचाव के उपाय

निम्नलिखित युक्तियों को अपनाने से यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचा जा सकता है-

(i) किसी अनजान व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों से यौन सम्बन्ध (multiple sex relation) न रखें।

(ii) मैथुन के समय कण्डोम (condoms) का उपयोग करें।

(iii) रोग की आशंका होने पर तुरन्त योग्य चिकित्सक से सम्पर्क करके पूरा इलाज कराएँ।

Q

3.11

True or false - reproductive health statements

निम्न वाक्य सही हैं या गलत, व्याख्या सहित बताएँ-

भाग (क)

गर्भपात स्वतः भी हो सकता है (सही/गलत)

स्वतः गर्भपात (Miscarriage) सही।

कुछ परिस्थितियों में कुछ कार्याकीय कारणों से गर्भपात स्वतः भी हो जाता है, इसे स्वतः गर्भपात या मिसकैरिज (miscarriage) कहते हैं।

तकनीकी रूप से जीवनक्षम (गर्भाशय के बाहर स्वतन्त्र रूप से रहने में अक्षम) या 28 वें सप्ताह से पहले स्वतः होने वाला गर्भपात अकाल प्रसव कहलाता है।

भाग (ख)

बन्ध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं/दोषों के कारण होती है।

(सही/गलत)

निष्कर्ष

गलत।

बन्ध्यता की परिभाषा सही है लेकिन कारण गलत है।

बन्ध्यता स्त्री या पुरुष किसी की भी जननिक असामान्यताओं या दोषों के कारण हो सकती है।

पुरुषों में शुक्राणुओं का न होना या कम होना, नपुंसकता आदि प्रमुख कारण हैं।

भाग (ग)

एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्णरूप से स्तनपान कराना सहायक होता है।

(सही/गलत)

स्तनपान: प्राकृतिक गर्भनिरोधक सही।

शिशु को पूर्णरूप से स्तनपान कराना एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय है।

इसके कारण अण्डोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता।

प्रसव के बाद लगभग 4 से 6 माह तक यह उपाय सबसे अधिक सफल रहता है।

इस अवधि में गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं।

भाग (घ)

लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है।

(सही/गलत)

निष्कर्ष

सही।

जनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए यौन-सम्बन्धित पहलुओं की जानकारी एक प्रभावी उपाय है।

इससे जनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ कम होती हैं या समाप्त हो जाती हैं।

यह लोगों को अनेक अन्धविश्वासों से भी बचाती है।

यह जनन अंगों की संरचना, ऋतुस्राव चक्र, गर्भनिरोधक और सगर्भता आदि की जानकारी देती है।

Q

3.12

Correct the following statements

निम्नलिखित कथनों को सही करें-

भाग (क)

गर्भनिरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं।

निष्कर्ष

शल्य क्रियात्मक उपाय से युग्मक (शुक्राणु/अण्डाणु) बनना नहीं रुकता।

इनसे केवल युग्मकों का परिवहन (संचार) या स्थानान्तरण रोका जाता है।

इसके फलस्वरूप गर्भाधान नहीं होता।

भाग (ख)

सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं

निष्कर्ष

यकृत शोथ-बी (hepatitis-B), जननिक हर्पीज (genital herpes) तथा एचआईवी संक्रमण (HIV infection) को छोड़कर अन्य यौन संचारित रोग पूर्ण रूप से उपचार योग्य हैं।

भाग (ग)

ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के रूप में गोलियाँ (पिल्स) बहुत अधिक लोकप्रिय हैं।

निष्कर्ष

ये शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं।

लेकिन जागरूकता की कमी व अशिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हैं।

भाग (घ)

ई टी तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है?

ET/ZIFT/IUT

ई० टी० (Embryo transfer) तकनीक में शरीर से बाहर अण्ड का निषेचन (पात्रे-निषेचन — in vitro fertilization) कराया जाता है।

इसके बाद युग्मनज (zygote) या 8-कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका (fallopian tube) में स्थानांतरित किया जाता है।

इसे जाइगोट इन्ट्रा फैलोपियन ट्रांसफर (ZIFT) कहते हैं।

जब भ्रूण में ब्लास्टोमीयर की संख्या 8 से अधिक हो जाती है, तो भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है।

इसे इन्ट्रा यूटेराइन ट्रांसफर (Intra Uterine Transfer : IUT) कहते हैं।